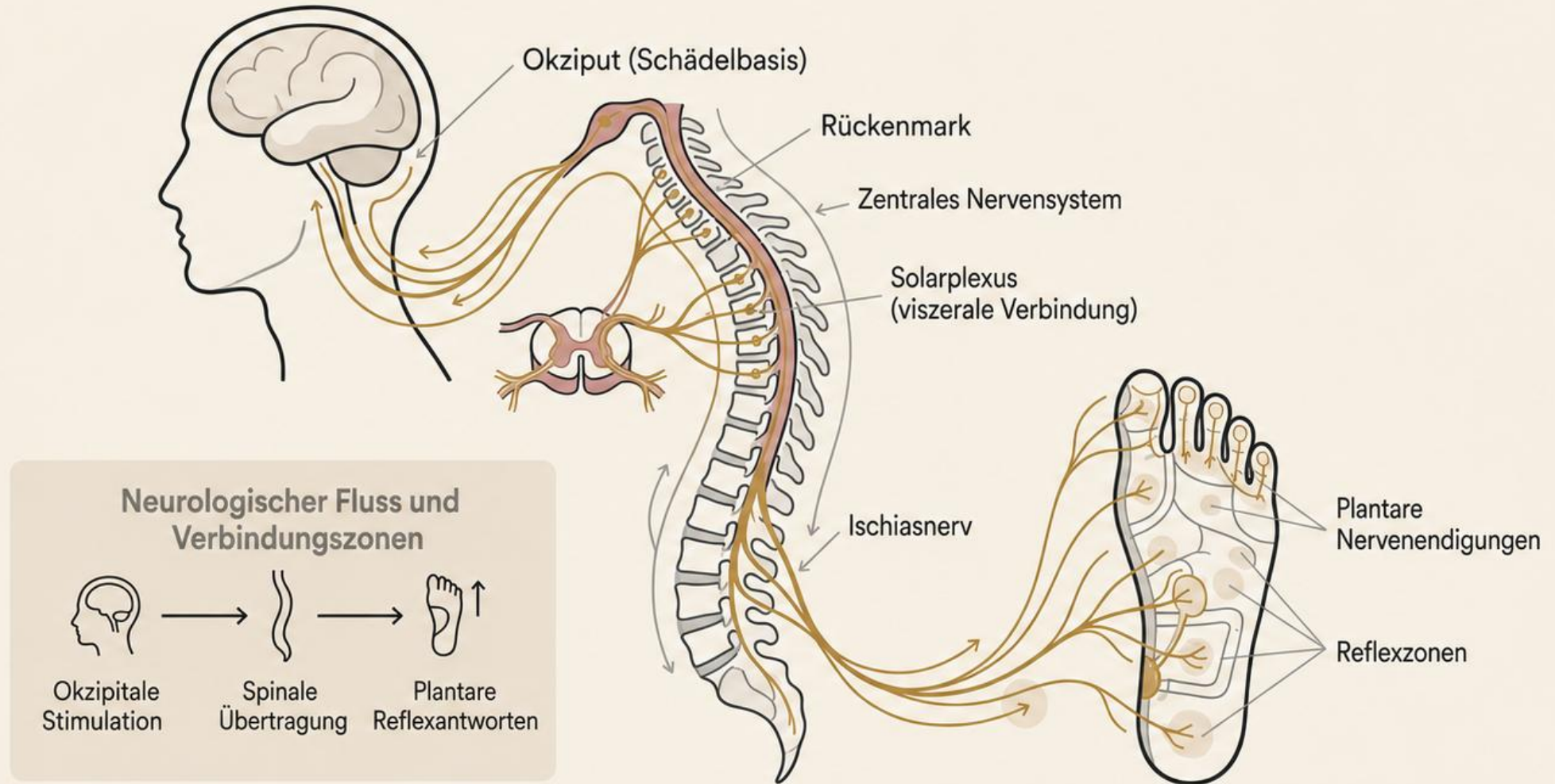


Behandlung durch die Okzipito-Podale Reflextherapie (ROP)

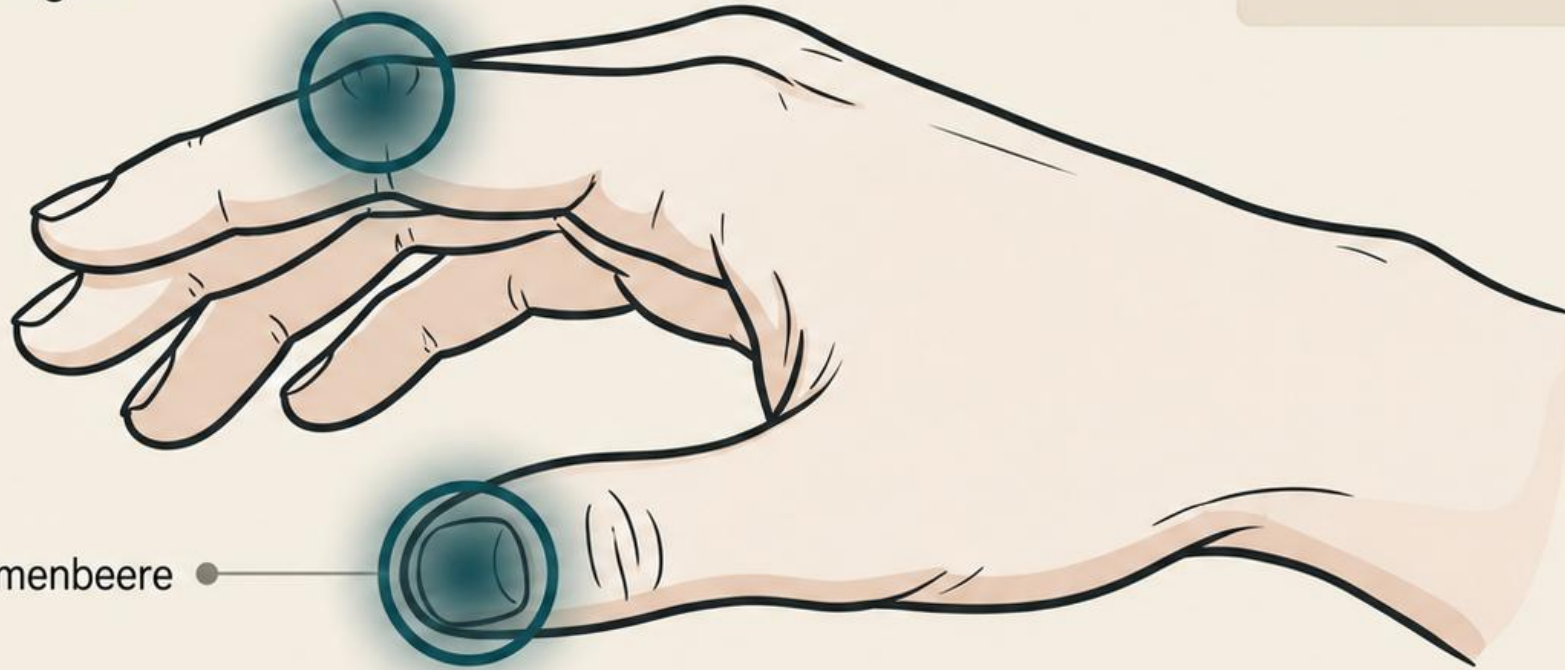
Kapitel 2 — Prinzipien, Kartographie und Klinik



Die Präzision der therapeutischen Geste

Proximales
Interphalangealgelenk
des Zeigefingers

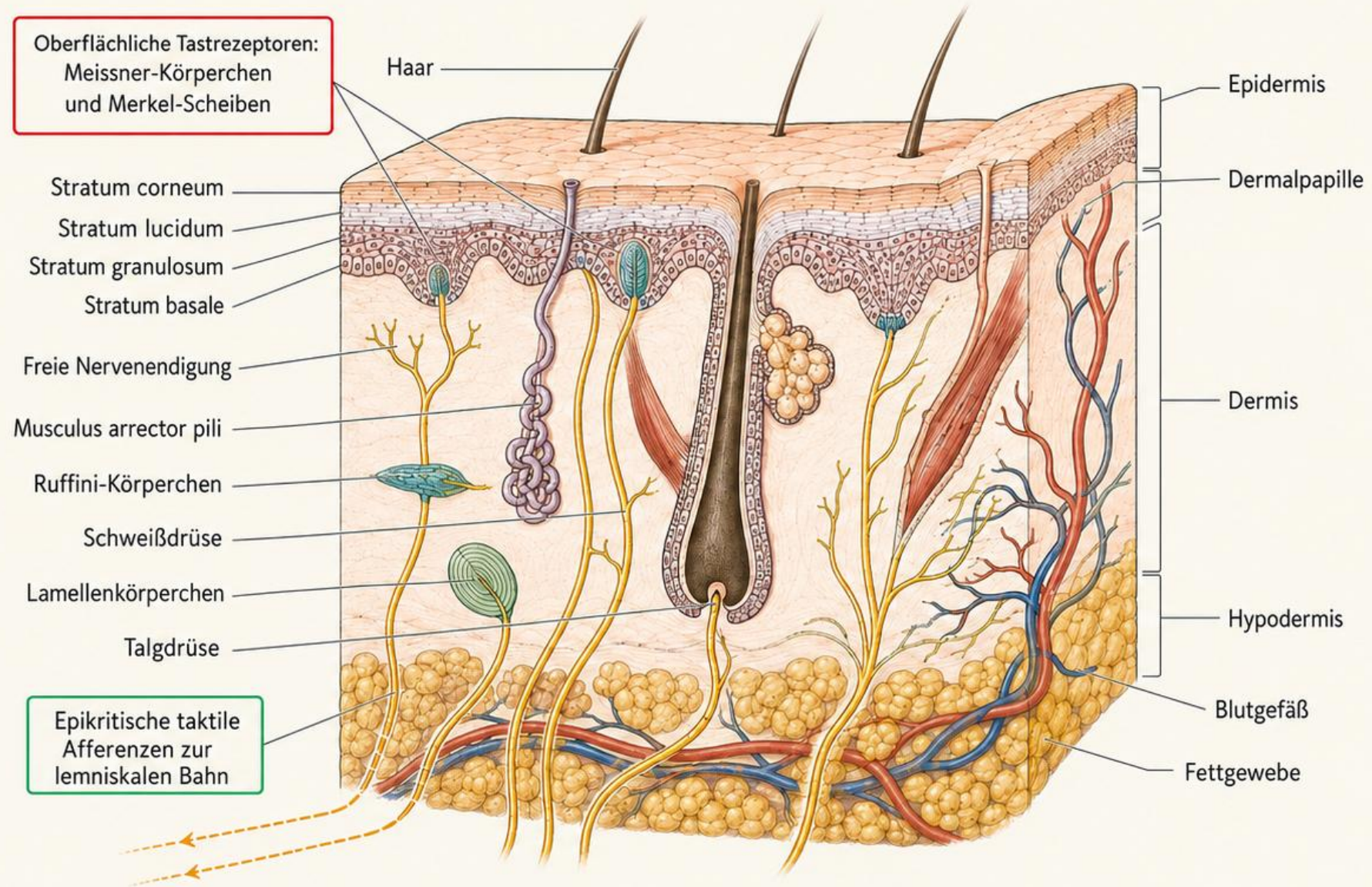
Daumenbeere



Ein ausschließlich manueller
Ansatz, ohne Zusatz von Öl oder
Creme, beruhend auf der Präzision
des epikritischen Drucks.

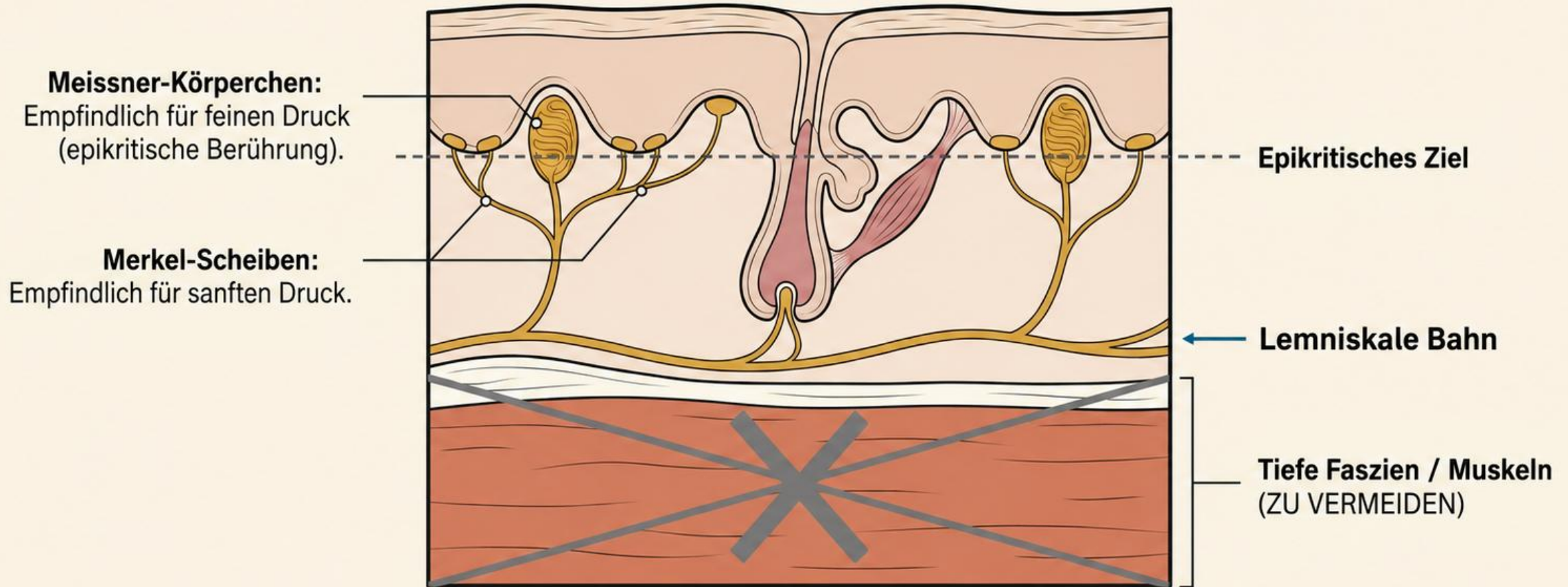
Kraft und Kneten sind kontraindiziert. Je stärker der Druck, desto schwieriger wird die Erfassung der knöchernen Orientierungspunkte und der Reflexzonen.

Die Haut



Schematische Darstellung der Hautschichten,
ihrer Anhangsgebilde und ihrer wichtigsten oberflächlichen Tastrezeptoren.

Das Gewebeziel: Epidermo-dermale Schicht



Ziel ist die Verformung der Haut, erkennbar an der Empfindung einer "Trommelhaut".
Je stärker der Druck, desto mehr verschwindet die Wahrnehmung knöcherner Orientierungspunkte.

Der neurologische Vektor

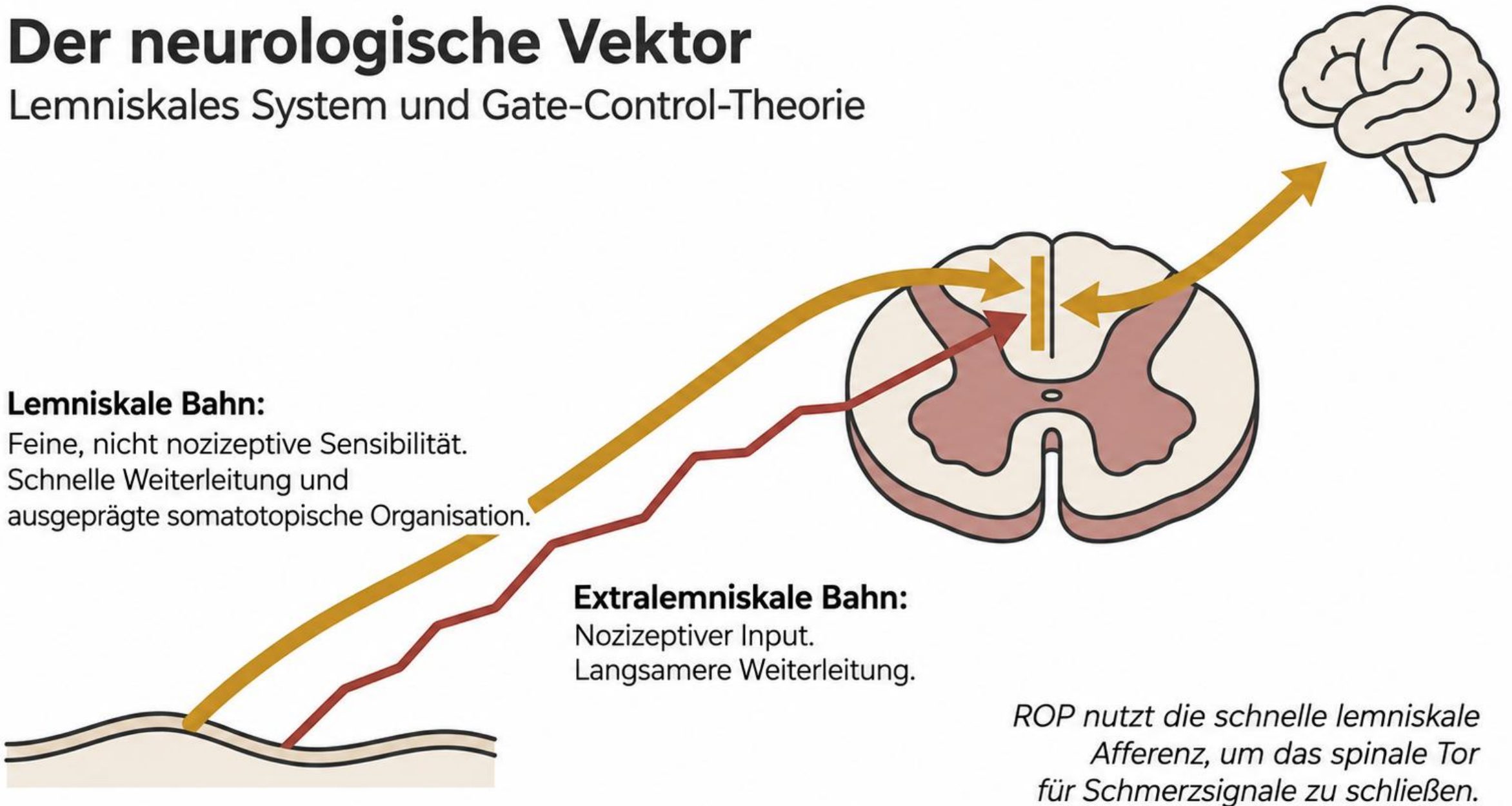
Lemniskales System und Gate-Control-Theorie

Lemniskale Bahn:

Feine, nicht nozizeptive Sensibilität.
Schnelle Weiterleitung und
ausgeprägte somatotopische Organisation.

Extralemniskale Bahn:

Nozizeptiver Input.
Langsamere Weiterleitung.



*ROP nutzt die schnelle lemniskale
Afferenz, um das spinale Tor
für Schmerzsignale zu schließen.*

Klinische Chronologie: Die drei Phasen der Massage



Texturdiagnostische Phase

Aktion: Suche nach Rauigkeiten, Verdichtungen und Gleitverlust.

Patientenempfinden:
Charakteristische Empfindung kleiner Nadelstiche.



Therapeutische Phase

Aktion: Feiner epikritischer Druck. Mobilisation der epidermo-dermalen Schicht.

Ziel: Stimulation der Mechanorezeptoren (ohne stechenden Schmerz, der auf Überdosierung hinweist).



Phase des „Abwartens“

Aktion: Poststimulatorische Latenzzeit. Nichts tun.

Ziel: Dem Organismus ermöglichen, die neurovegetativen Anpassungen zu integrieren.

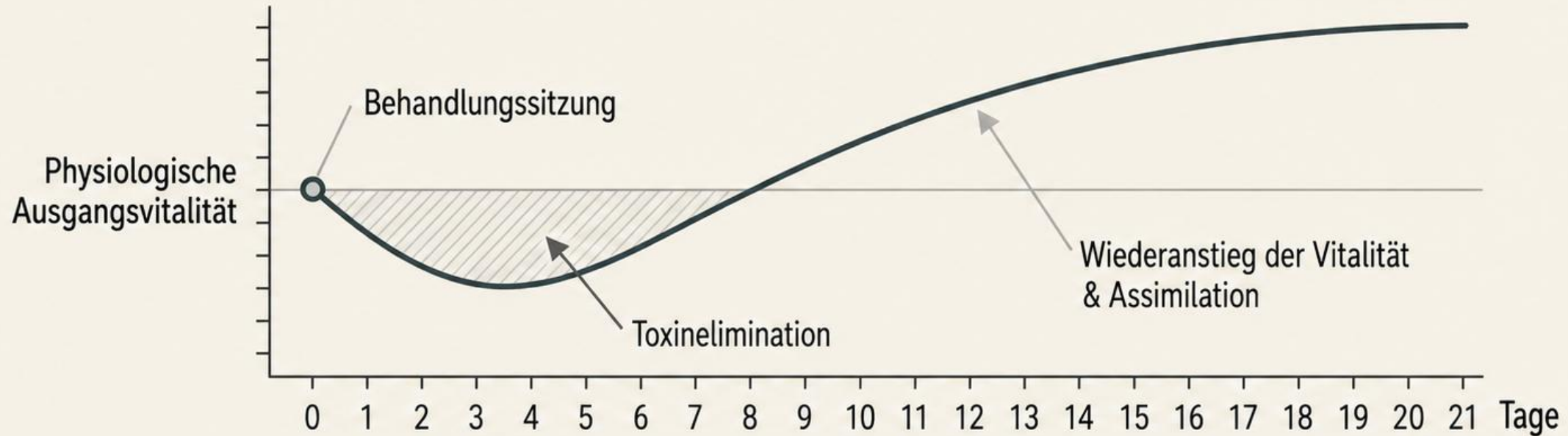
Ergebnis: Wiederhergestellte Geschmeidigkeit.



Das neurovaskuläre Assimilationsfenster

Warum ist ein Intervall von 3 Wochen erforderlich?

Adaptationskurve



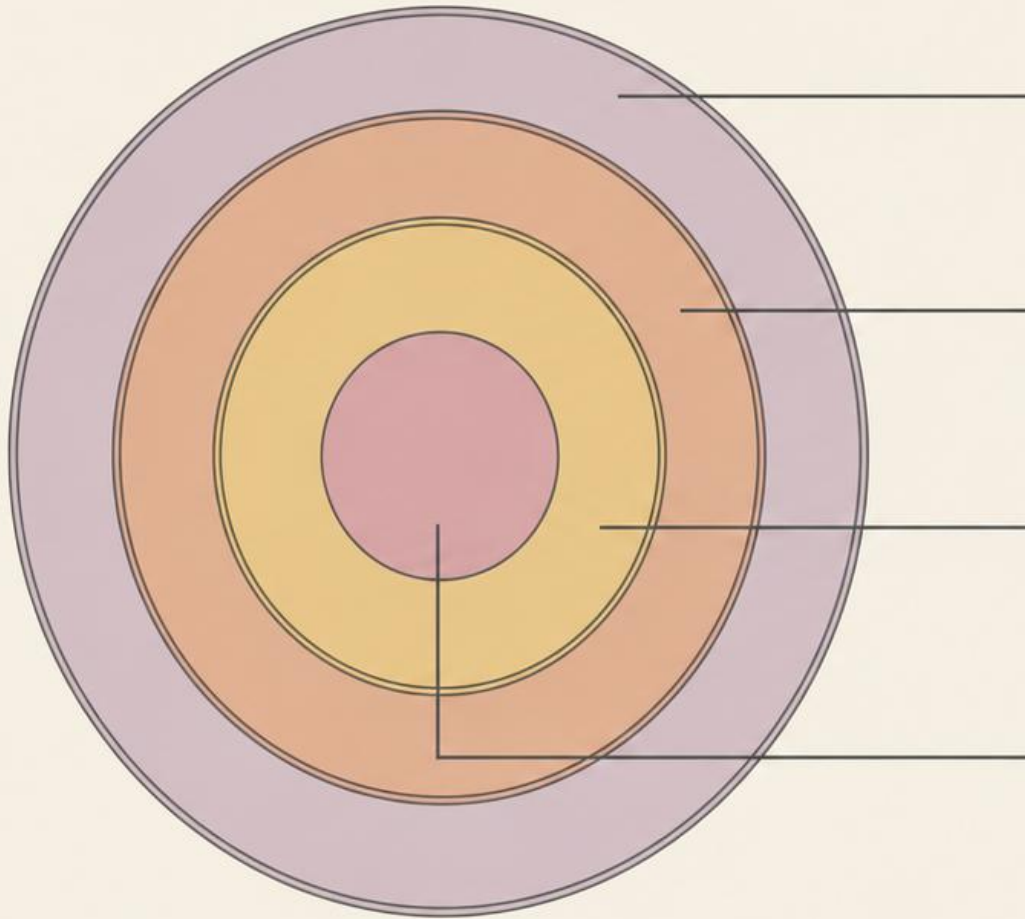
24 bis 48 Stunden: Mögliche vorübergehende Reaktionen (Muskelschmerzen, Müdigkeit, Träume). Dies zeugt von der Reaktion auf positiven Stress und von der Toxinelimination.

In den folgenden Wochen: Anpassung des immunologischen, hormonellen und psychischen Systems.

Zu eng aufeinanderfolgende Behandlungen lassen den neurovaskulären und strukturellen Prozessen nicht genügend Zeit, die Physiologie in den Viszera wiederherzustellen. Drei Sitzungen sind im Allgemeinen ausreichend.

Hierarchisierung des Behandlungsplans

Ein unveränderliches Protokoll existiert in einem ganzheitlichen Ansatz nicht.



1. Notfälle & Folgezustände: Posttraumatische Zustände, chirurgische Eingriffe, Infektion (sofortige Priorität).

2. Dominante Fixationen: Identifiziert durch die Anamnese und die globalen/lokalen Listening-Tests.

3. Psycho-emotionale Sphäre: Verdrängte frühere Traumata (Amygdala / Hippocampus).

4. Allgemeiner Kontext (SGA): Die vollständige Geschichte der Anpassungen des Individuums.

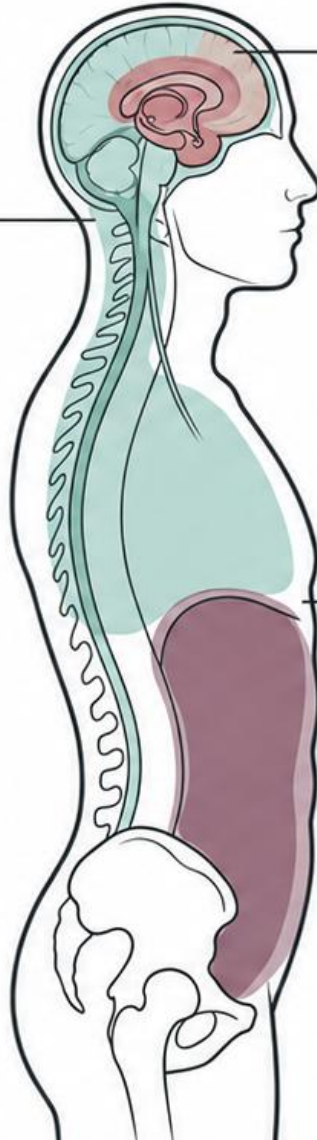
Interventionskartographie

Die drei okzipito-podalen Reflexsphären

1. Allgemeines Adaptationssyndrom (AAS)

Occiput-C1-C2, Nervus vagus (X), Falx cerebri, PRM, venöses System.

Ziel: Unterstützung der globalen neurovegetativen Regulation.



3. Limbisches System

Amygdala, Hippocampus, Insula. Gehirn-Viszera-Balance.

Ziel: Integration der Stressdimension und des Körpergedächtnisses.

2. Lokoregionales Syndrom

Prävertebraler Plexus, somatische Plexus, abdominale und pelvine Hohlräume.

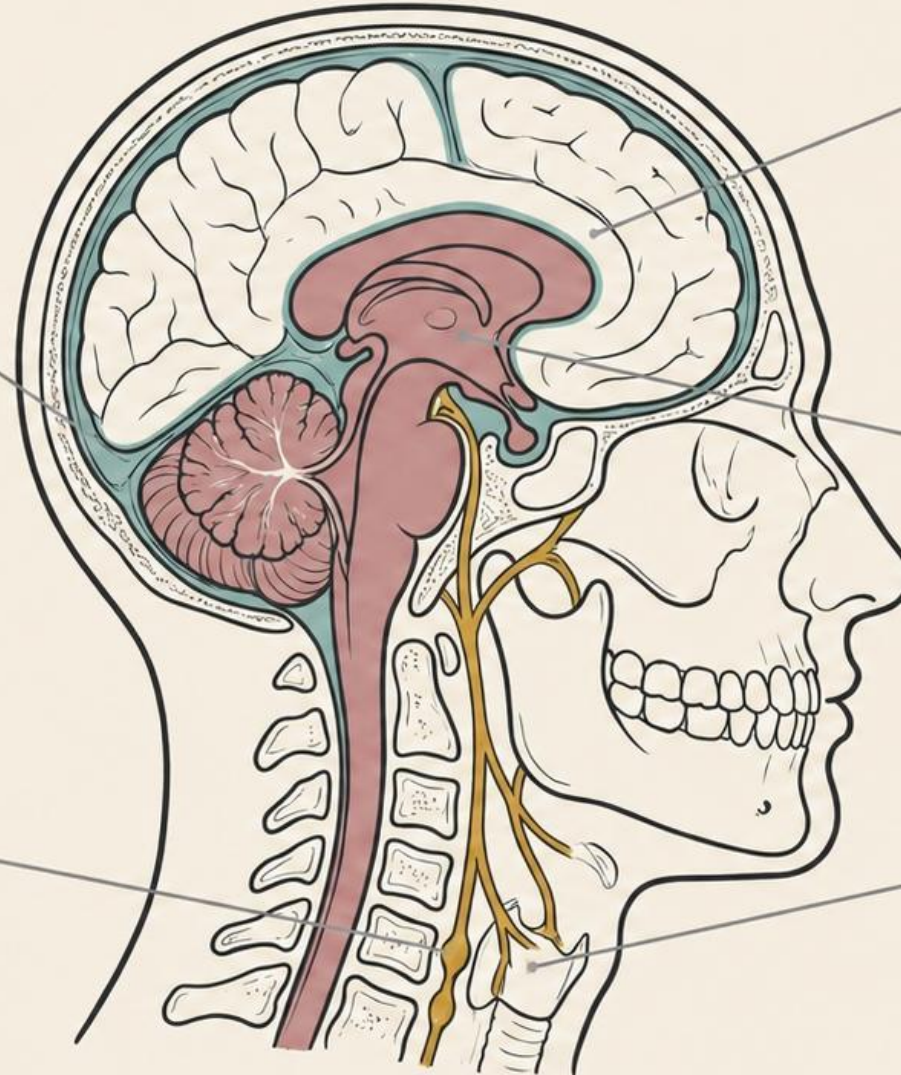
Ziel: Behandlung der viszerosomatischen Regelkreise.

Anatomische Ziele I: Allgemeines Adaptationssyndrom

Die neurovegetative Regulation unterstützen, bevor das lokale Gewebe behandelt wird.

PRM (Primärer Atemmechanismus):

Occiput-C1-C2, Hirnnerven
V, X, XII, Falx cerebri.



Liquor cerebrospinalis:

Venöses System, Kompression des
IV. Ventrikels, Synchronisation SSB-S2.

Übergeordnete Zentren:

Diencephalon, Hirnstamm,
Hypophyse.

Sympathische Innervation:

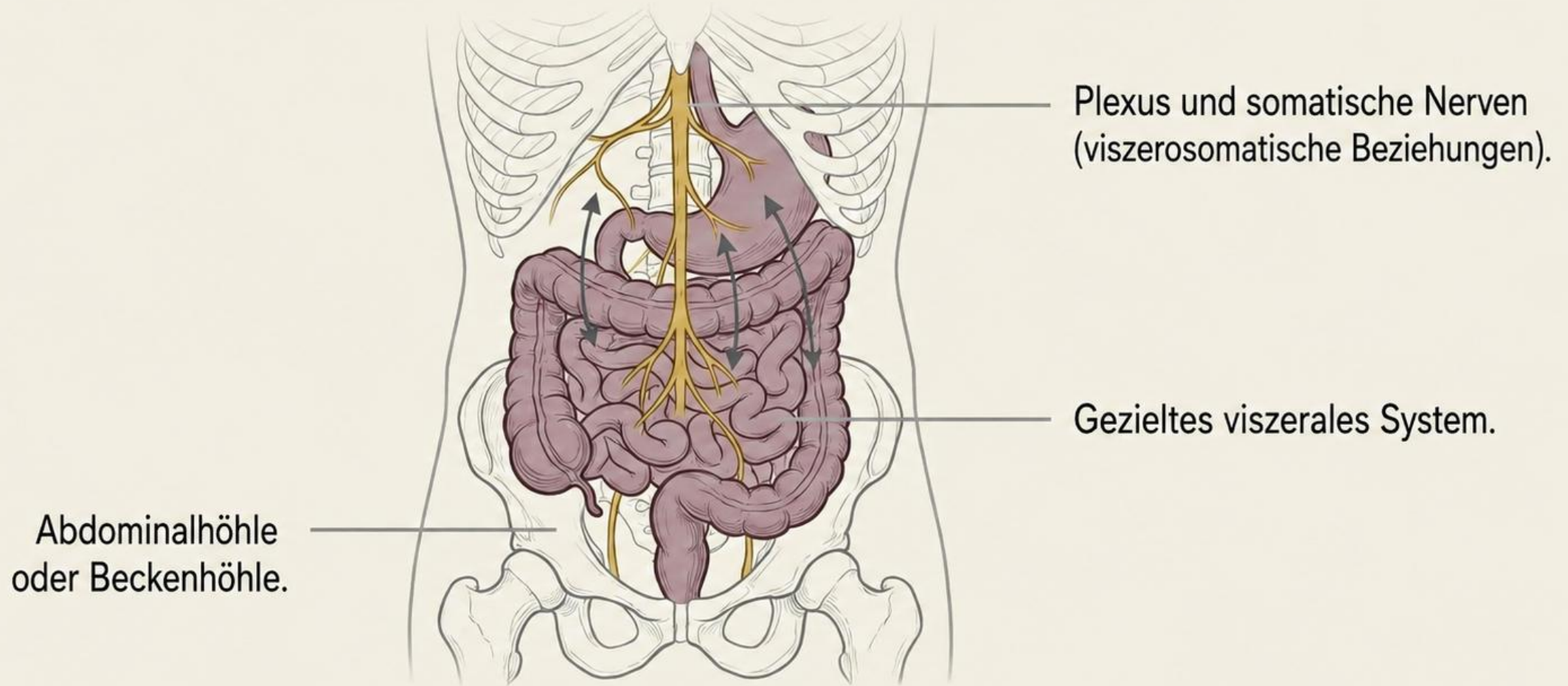
Wirbelsäule,
laterovertebrale Ganglienkette.

Neurovegetatives System:

Nervus vagus (Foramen magnum/
Jugularforamen, Hiatus oesophageus),
pelvines Parasympathikus-System.

Ziel II: Lokoregionales Syndrom

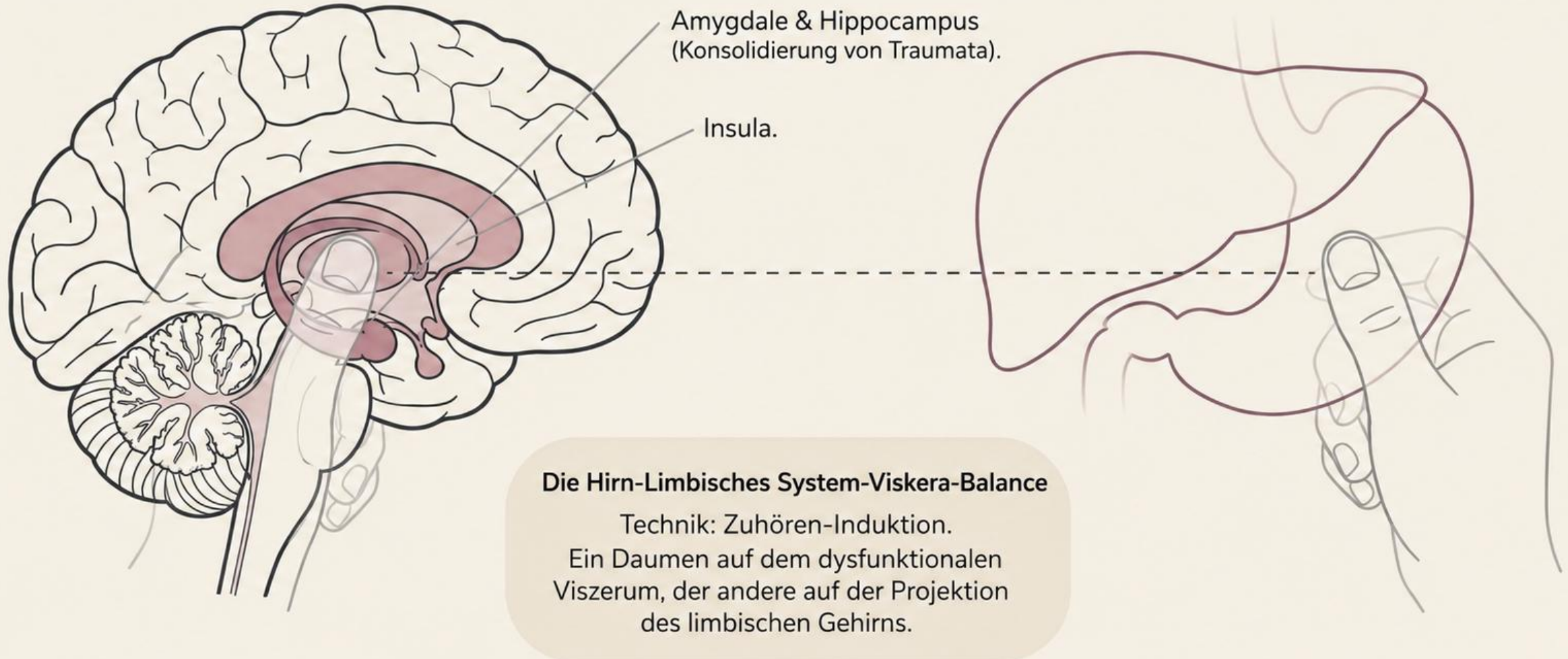
Behandlung der mit der symptomatischen Region verbundenen Schleifen.



Das Ziel besteht darin, lokale Fixationen in der betroffenen Höhle zu lösen, um die Gewebemobilität wiederherzustellen und die durch die Dysfunktion aufrechterhaltene neurovegetative Schleife zu unterbrechen.

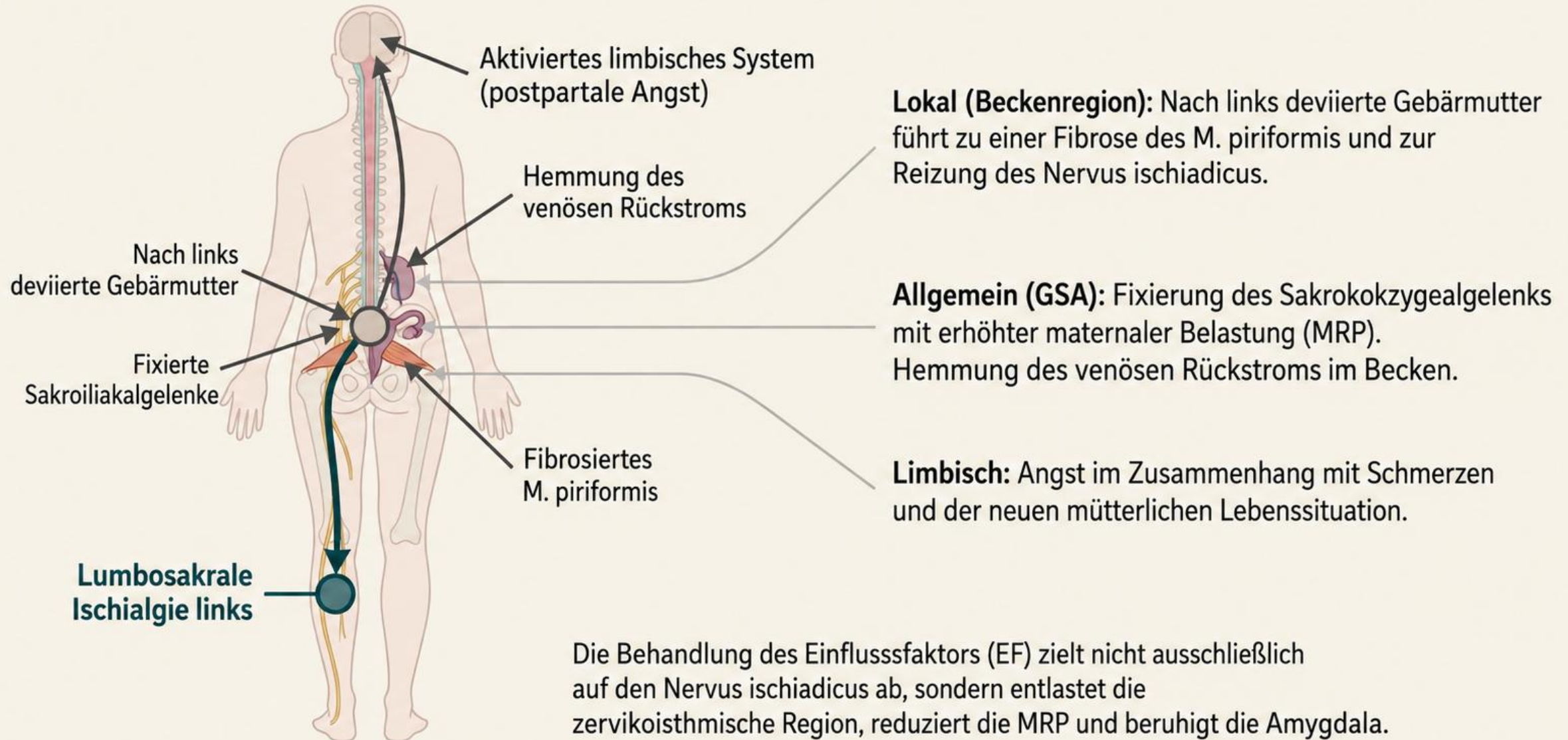
Ziel III : Limbisches System

Integration des Körpergedächtnisses.



Klinische Anwendung: Lumbosakrale Ischialgie nach der Geburt

Einseitige Patientin, ausgeprägte Schmerzen gemäß Belastung, langes Sitzen.



Der ROP-Behandlungsplan für Frau X

Säule 1: Allgemeines Syndrom — Grundlage

- Primäre Atemmuskulatur (PAM)
- Gehirn und Rumpf
- Hormonelle Achse: Hypophyse, Nebennieren
- Venöser Rückfluss: Leber, Niere (links)
- Wirbelsäule

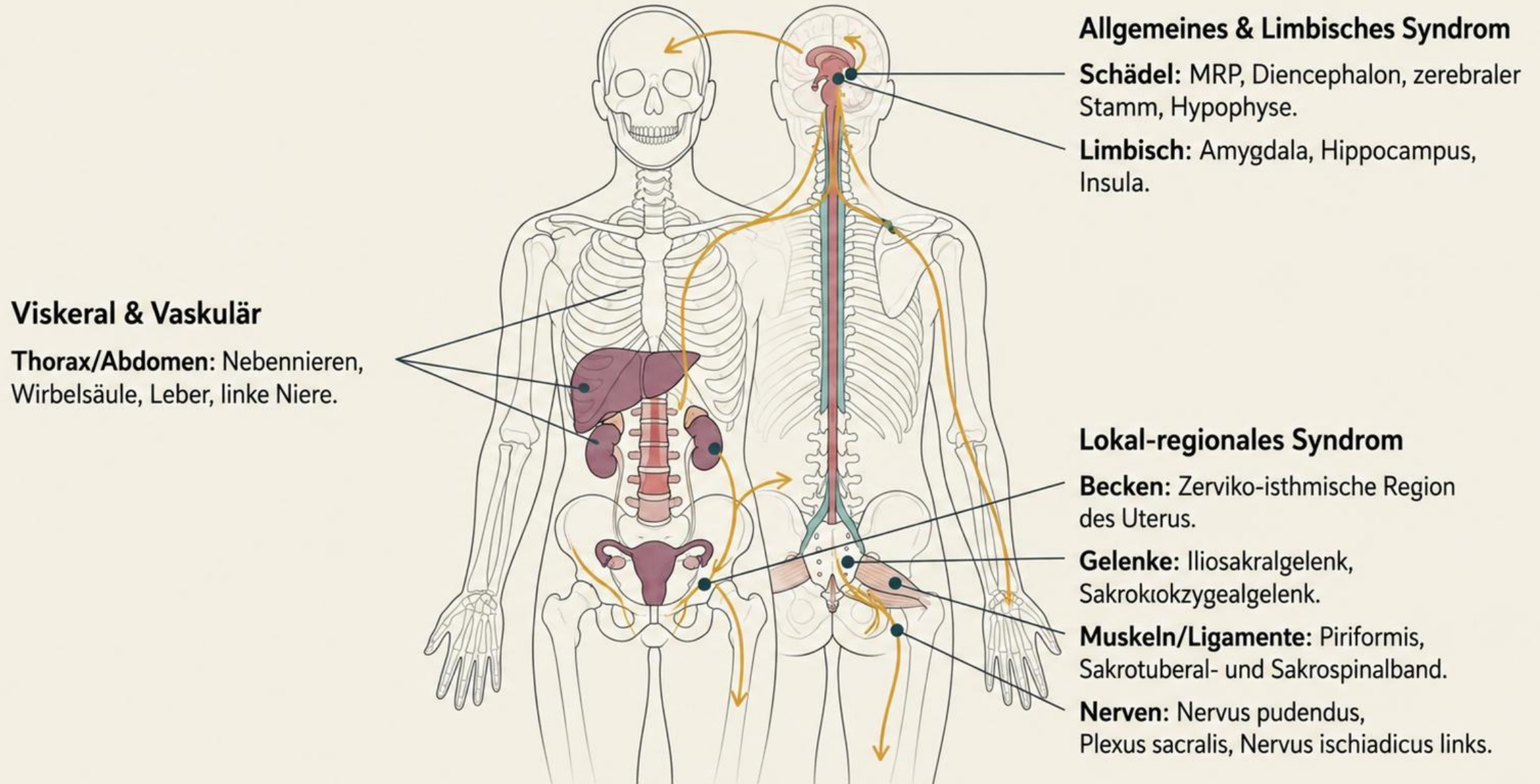
Säule 2: Lokoregionales Syndrom — Mechanisch

- Zerviko-isthmische Region der Gebärmutter
- Beckengelenke (Sakroiliakalgelenke, Sakrokokzygealgelenk)
- Piriformis-Muskel und sakrotubérale/sakrospinale Bänder
- N. pudendus und linker N. ischiadicus (Plexus)

Säule 3: Limbisches System — Integration

- Amygdala
- Hippocampus
- Insula

Behandlungsplan ROP (Anwendungsfall Frau X)



Therapeutische Indikationen: Der Bereich reversibler funktioneller Störungen

ROP ist besonders wirksam bei Ungleichgewichten des vaskulo-neuralen Systems, die der Erkrankung vorgelagert sind, wenn noch keine anatomische Gewebeveränderung eingetreten ist.



Muskuloskelettale Schmerzen: Lumbalgien, Zervikalgien, chronische Spannungszustände ohne wesentliche strukturelle Schädigung.



Posttraumatische Folgen: Osteo-muskulo-artikuläre Beschwerden oder reversible Beeinträchtigungen der spinalen und kranialen Nerven.



Viszerale Dysfunktionen: Neurovegetative Regelkreise und Gewebefixationen, die die Organmotilität beeinträchtigen.



Somatoviszerale Störungen: Übertragene Schmerzen zwischen dem Soma und den metameren Viszeralhöhlen.



Neurovegetatives Terrain: Emotionaler Stress, Angst und Dysregulation des Allgemeinen Adaptationssyndroms.

Klinische Governance: Sicherheit und Grenzen

✓ Indikationen (Funktionelle Versorgung)	+ Warnzeichen (Medizinische Überweisung erforderlich)
Reversible und extrazelluläre Pathologien.	Nicht-mechanische Schmerzen, die nachts schlimmer werden.
Muskuloskelettale Schmerzen und Traumafolgezustände.	Atypische thorakale Schmerzen, Dyspnoe.
Viszerale Dysfunktionen und neurovegetative Ungleichgewichte.	Blut im Urin/Stuhl, Fieber, unbeabsichtigter Gewichtsverlust.
Emotionaler Stress und Angst.	Neurologisches Defizit (Störungen der Schließmuskelkontrolle/Sensibilitätsstörungen).
Integrative Unterstützung (z. B. Einschränkung postoperativer iatrogenen Effekte).	

Primum non nocere. Jeder Verdacht auf organische Pathologie erfordert eine medizinische Reorientierung.

Globale Begleitung des Patienten



Ruhe und Regeneration (ROP):

Vermeiden Sie körperliche Überlastung im Laufe des Tages.



Mentale Gesundheit:

Werden Sie aktiver Gestalter Ihrer Gesundheit, fördern Sie positive Gedanken, pflegen Sie Ihr emotionales Wohlbefinden.

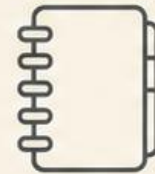
*« Bevor Sie versuchen,
jemanden zu heilen,
fragen Sie ihn, ob er bereit ist,
auf die Dinge zu verzichten,
die ihn krank gemacht haben. »*

— Hippokrates



Lebensstil und Hygiene:

Gesunde Ernährung, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, regelmäßige körperliche Aktivität.



Selbstbeobachtung:

Beobachten Sie Ihre Entwicklung bis zum nächsten Termin (Schmerz 0-10, Schlaf, Transit, Energie). Zielgerichtete Beobachtung unterstützt zukünftige Entscheidungen.